جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : علية الشوادفي فايد مسعود
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** امبابه **العنوان :** امبابه
رقم البطاقة : 28308141303708 **رقم التليفون :** 01002224052 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 14-08-1983 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: علية الشوادفي فايد مسعود
National ID: 28308141303708

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



National ID · Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]



National ID · Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Name: عليه الشوادفي فايد مسعود **MR. :** 1734	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 42-year-old individual with right-sided invasive ductal carcinoma of the breast, estrogen-receptor score 8/8, progesterone-receptor score 7/8, and HER2-positive disease, staged clinically as cT2 N0 M0. Neoadjuvant chemotherapy consisting of six cycles of taxol and four cycles of carboplatin was completed on 16 February 2023, followed by right-breast breast-conserving surgery with sentinel lymph-node biopsy performed in March 2023, revealing ypT0 ypN0 with 0/12 nodes positive. Post-operative radiotherapy was delivered in 20 fractions. The patient has been maintained on an aromatase inhibitor (Femara) since April 2023, supplemented with calcium and vitamin D (Calcium One Alpha) and a subcutaneous bisphosphonate (Zolendex 10.8 mg) for bone health.

Adjuvant therapy continues with Zoladex and Femara, with the next clinic visit scheduled for 16 August 2026.

The current plan is to continue Femara and to provide supplemental therapy with Zoladex for three months, with Zoladex due on 16 August; the patient will be seen in the pharmacy clinic on 20 October.

تحريرا في ,

التاريخ :	**18-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : **ايه مدحت بدوي محمد**

يعتمد ,

Patient Name	: الأستاذة / عليه الشوادفي فايد مسعود	Request No.	: 13002042
Patient No.	: 28308141303708	Request Date	: 22/03/2023
Path No.	:	Verification Date	: 01/04/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - تغطية الدولة
Age	: 39 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Right breast cancer post NACT
Nature of the specimen:
Right BCS & Rt ALND .
Gross Examination:
- Procedure: Rt BCS specimen measured 10x7 cm (wire guided) , not covered by skin .
- Tumor extent : A greyish white tumour bed site measured 7.5x5.5 cm .
- Distance from margins: Away from medial margin by 0.1 cm and away from superficial margin by 0.1 cm .
- Lymph nodes number and size: Axilla : Fibrofatty tissue piece measured 10x8 cm enclosing 12 ALNs up to 1x1 cm .
- Frozen section: Free margins

Microscopic examination:
- Histological type: No residual of invasive tumour tissue detected (Total tumour regression)
- Ductal carcinoma in situ: Small focus (High grade)
- Lymph node involvement: Free ALNs (0/12)
- Resection Margins: Free margins
- Histologic response to therapy: Pathologic complete response
- Additional pathologic findings: Microcalcification

Diagnosis:
Right breast cancer , Right BCS & Rt ALND .
- No residual of invasive tumour tissue detected (Total tumour regression)
- Small focus of DCIS (High grade)
- Free margins
- Free ALNs (0/12)

Verified by :
dr.esraa magdy

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: Aleya El shawadfy

Date: 8/3/2023

Contrast enhanced Spectral Mammography

CLINICAL SUMMARY: Right breast cancer pathologically proved to be invasive duct carcinoma.

TECHNIQUE: CC & MLO low energy & recombined (post contrast) images

FINDINGS:

Background Uptake: mild background enhancement

ACR: c (Heterogeneously dense breast parenchyma)

RIGHT BREAST:

- **Low energy (Non contrast) images:** show upper outer and upper central inserted clip with scattered punctate and linear microcalcifications extending beyond the most inner clip by about 1.4 cm.
- **Recombined (Post contrast) images:** no corresponding pathological mass or non-mass enhancement in today's study.
- **Complementary US:**
  - Still noted upper outer quadrant residual hypoechoic altered parenchyma with calcific foci, yet no notable related vascularity.
  - Upper outer quadrant intra-mammary lymph node is noted showing average cortical thickness and preserved fatty hilum.
  - Variable sized level I axillary lymph nodes showing lobulated cortical thickening reaching 3 mm, yet with preserved fatty hila.
- Normal skin / nipple / areolar complex.

LEFT BREAST:

- **Low energy (Non contrast) images** No masses, asymmetry or distortion or suspicious calcifications.
- **Recombined (Post contrast) images** show, no pathological uptake.
- Normal skin / nipple / areolar complex.

IMPRESSION:

RIGHT BREAST: Status post NACT for right breast cancer showing near total complete radiological response (BIRADS 6= Pathologically proven malignancy)

LEFT BREAST: No pathologically enhancing lesions (BIRADS 1= Normal)

Best regards,

Dr. Sherihan Fakhry, MD

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

Patient Name: Aleya Al Shawadfy Fayed Masoud	Date : 28/02/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 39 Year(s)
Medical ID: 3926/2022	Pat. ID: 25309

DIGITAL BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

Indication:

Post NACT status assessment of a known right breast multicentric malignant masses

Report:

- ACR b: scattered fibro-glandular parenchyma of both breasts
- Right breast:
  - Right breast UOQ & UIQ metallic clips and clusteres of microcalcifications over an area measuring about 65x60x50mm in APxTSxCC dimensions respectively about 40 mm from the nipple. Ultrasound shows parenchymal distortion at 12O'clock with no definite residual mass.
  - An enlarged intra-mammary LN is noted at 10O'clock showing preserved fatty hilum and normal cortical thickness
  - No pathologically enlarged axillary lymph nodes
- Left breast:
  - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
  - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
  - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
  - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post NACT status of right breast showing marking clips and residual malignant widely spread microcalcifications with indeterminate intra-mammary lymph-node (BIRADS 6)
- Normal sonomammography of right breast (BIRADS 1)

Best regards,

Dr Amira H Radwan MD

28/2/2023

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

PATIENT NAME: Aleya El Shwadfy FAIED MASOUD GENDER: Female AGE: 39 y	PATIENT ID #: 2022201295 ORDER #: 1876206 DATE OF SERVICE: 29-Sep-2022 01:28 PM

Report:

99mTc-MDP BONE SCAN

Desired Information :- skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 minutes & 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99mTc-MDP :

FINDINGS:-

Degenerative changes at dorso- lumbar vertebrae.

Arthritic changes at knees & shoulders.

Both kidneys are seen.

Conclusion: -

No definite evidence of metastatic bone deposits.

Reported By,

Ass. Prof. Huda Fathy Elsayed **29-Sep-2022 02:55 PM**

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECHON SUPPORT

تاريخ الاصدار :24-8-2023

جهه الاصدار :فرع الجيزة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التامينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) عايده الشوادفى فايد بطاقة رقم 28308141303708

وطبقا الى خطاب من التامينات الإجتماعية وارد عدم الأنتفاع

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون اى مسئولية على الهيئة العامة للتامين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التامين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :24-8-2023

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية لنظم المعلومات
ودعم القرار

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 972424

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

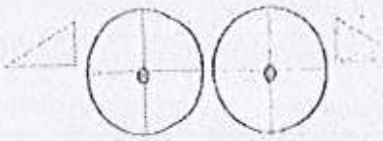
Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID: 3- Medical number: 83099286
1- Name : Sex: Female Old Med : 3926/2022
2-ID number: 28308141303708 Patient Age : 40 Y



Family history | Phone 01159113194 01156029263 | BMI | REASON OF MDT POST OPERATIVE
marital status | NRS Score | GROUP | Date of MDT 04/13/2023
Co morbidity obese | Menopausal status

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :
INITIALLY MULTICENTRIC BREAST CANCER

BX:	ER:	PR:	Her 2 Neu :	SISH :	KI67 :
IDC	8/8 +ve	7/8 +ve	3 +ve		

T	N	M
ct2	0	0

Sonomammography
28/2/2023---POST NACT OF RT BREAST SHOWING MARKING CLIPS & RESIDUAL MALIGNANT WIDELY SPREAD MICROCALCIFICATIONS WITH INDETERMINATE INTRA-MAMMARY LN

PATIENT HISTORY
PT RECEIVED 6 CYCLES TAxOL/CARBO
4 CYCLES HP ENDED 16/2/2023
rt BCS+SLNB:
NO residual invasuve tumor tissue
total regression
small focal Dcis (HIGH GRADE)
free margins ALND 0/12 (YPTONO)

MDT OUTCOME & PLAN

1- PORT
2-ADJUCANT HERCEPRTN TO COMPLETE 1 YEAR
3-ADJUVANT ZOLADEX FEMARA

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/	RADIOLOGY	د/
SURGERY	د/	PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]